

소아과 1주차 SUMMARY 공지사항

- 이번 학기는 소아과가 3시간...! 다들 파이팅입니다 ㅎㅎ

1절 개요

① 소화기계의 기능

: 물리적, 화학적으로 복잡하게 구성된 음식물을 소화&흡수하여 수많은 체세포가 쉽게 대사에 사용할 수 있도록 도와줌

② 구성

- 소화관: 입에서 항문에 이르는 긴 관(입,인두,식도,위,소장,대장)
- 식도: 입에서 씹어 삼킨 음식을 위까지 전달
- 위장: 기계적 작용과 펩신이라는 소화효소를 통해 음식물을 그 크기가 1mm 이하의 작은 입자로 만들어 소장으로 내려보냄
- 소장: 췌장 소화효소 및 소장점막의 소화효소에 의해 영양분이 흡수의 초소단위인 아미노산, 당당류, 지방산 등으로 분해되고, 수분, 전해질, 비타민 등과 함께 영양분 흡수
- 대장: 소화과정에서 생긴 노폐물과 체세포의 대사과정에서 생긴 부산물을 배설 제거

③ 한의학에서의脾胃

- 脾: 運化輸布(운화수포)를 主 → 四肢를 溫陽하여 四肢肌肉을 주관 // 開竅瘀口, 其華在脣, 統血, 脾藏意하여 사유활동과 깊은 관계
- 胃: 受納腐熟(수납부숙)을 主
- 脾氣는 상승하고, 胃氣는 하강하여 소화/흡수/수송/영양의 기능을 완성함

2절 腹痛

1. 개요

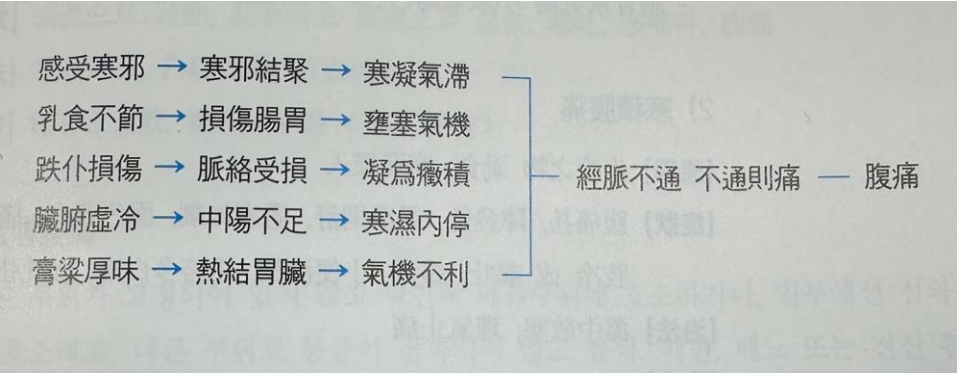
- 腹痛: 胃脘以下, 臍의 四傍 및 臍下 小腹部에 疼痛이 발생하는 病症
- 여러 질병의 발생과정에서 나타나는 하나의 증상
- 복부는 諸陰之會
- 大腸은 臍部以上 / 太陰에 속함 / 食積外邪
- 臍腹은 臍部周圍(제부주위) / 少陰에 속함 / 積熱炎火
- 小腹은 臍部以下 / 厥陰에 속함 / 瘀血, 痰, 尿澀

- 소아는 나이가 어릴수록 복통의 통증 부위를 정확히 표현하지 못하며, 영아에서는 몹시 보채거나, 안절부절하여 불안해하거나, 날카롭게 혹은 계속 울거나, 하지를 움츠리고 대퇴를 복부에 붙이고 식욕을 잃고 먹지 않으려 하는 등의 증상만으로 복통을 추측해야 하는 경우가 多

- 신체의 다른 부위의 통증을 복통을 호소하기도 함
- 임상적 진단이 곤란한 경우가 많음 → 반드시 '四診'을 통한 전반적 진찰 必
- 발병경과, 복통의 성질(둔통, 지속성, 陣發痛 등), 수반증상(구토, 설사, 변비, 농혈변, 발열)에 주의하며 복통과 관련된 급성질병(충수염 등)을 판단해야 함

2. 病因病理 (병인병리)

- 대부분 외감(寒氣)과 내상음식, 蟲, 打撲損傷, 停食感寒, 기체혈어, 장부허랭의 원인으로 氣機鬱滯하여 血流不暢(혈류불창), 經脈不通하고 '不通則痛'하여 발생
- 복통의 병변은 주로 脾와 六腑에 있음
- 병의 발생은 주로 다양한 원인으로 인한 氣滯로 인해 발생
- 병기의 분류에서는 寒熱의 구분이 중요하며, 복통의 성정은 虛實로 구분
- 치료원칙: 調理氣機, 疏通經脈 위주



3. 辨證施治

(1) 식적복통

증상	식후 위완부 통증 + 누르면 심해짐 트림·변이 시큼 설사 후 통증 감소 트림과 방귀 잦다 복부팽만 대변비결 희음냉수 음식 생각 X 깊은 잠을 잘 못 잠, 정신 피곤, 면색황(黃) 설태다후니, 맥현침활긴
치법	소도적체 행기지통
치방	향사평위산, 보화음 소승기탕, 대화중음

(2) 한적복통

증상	극심한 복통, 진발성 배를 따뜻하게 하면 好 • 차갑게 하면 더욱 甚 소변맑음, 면색 창백, 손발冷 입술 암자색 설태다백활, 맥침현긴
치법	온중산한 이기지통
치방	곽향정기산, 정기천향산 양장산, 반충산

(3) 실열복통

증상	누르면 동통 조열, 손발바닥 뜨거움 변조, 갈증 호소, 대변비결 입술과 혀가 붉다 태황조, 맥활삭 or 맥침실
치법	통부설열 행기지통
치방	조위승기탕, 대승기탕, 증액승기탕, 대시호탕

(4) 장부허랭복통

증상	은은한 복통 반복(腹痛綿綿) 배를 누르거나, 따뜻하게 하거나, 음식 먹으면 복통 감소 손발이 참 면색광백(晄白), 정신권태 설담태백, 맥침지세
치법	온중보허 산한지통

치방	향사육군자탕, 전씨백출산, 삼출건비탕 건리탕, 당귀산
----	----------------------------------

(5) 내식외한복통

증상	표(表) - 오한발열 리(裏) - 오식(惡食), 구토, 제규(啼叫)
치법	발산외한 내소식체 해표소중
치방	곽향정기산 곽향화중탕

(6) 기체복통

증상	통증부위 고정X (막연히 배꼽주위, 일부 심와부) 다른부위 통증전파X 음식/배변/배뇨 활동 연관 없음 양옆구리와 소복이 당기며, 트림 or 방귀 후 통증감소 설담, 태백, 맥현
치법	實 - 서간화위, 소간화비 虛 - 건비양심, 익기보혈
치방	實 - 시호소간탕 虛 - 향사육군자탕, 가미귀비탕

(7) 혈어복통

증상	통증위치가 고정 침으로 찌르는 듯한 통증, 누르면 아픔, 덩어리(塊) 만져짐 입술색이 어두움 설자암유어점
치법	활혈화어
치방	소복죽어탕

(8) 충통

증상	복통 반복 맑은 물을 토함 식욕 종으나 몸이 마름 異味症 (이 상한 맛이 느껴짐), 蟲斑 불면 얼굴색이 붉었다가 파랗다가 하얗다
치법	안회지통
치방	오매환, 비아환

4. 鍼灸治療

사관혈 + 중완혈 정도 언급하고 빠르게 넘어가심

5. 복통에 대한 이해

1) 급성 복통	2) 만성 반복성 복통
1) 급성 충수염 2) 장중첩증 3) 장간막 림프절염 4) 장폐쇄증 5) 급성 위장염 6) 변비 7) 급성 감염성 질환 8) 전염성 간염 9) Henoh-Schonlein 자반증 10) 심인성 복통 11) 기타	(1) 기능성 반복성 복통 ★ (70-75%) : 발작 복통 / 비궤양 소화불량증 / 과민장증후군 (2) 기질적 원인에 의한 반복성 복통의 특징 ★ (10%)

1) 급성 복통

- 위장관 긴장이나 신장(stretching), 염증 또는 허혈에 의한 통증 신호가 구심 신경을 탐 → 후근신경절(dorsal root ganglia) → 척수를 가로질러 연수, 중뇌, 시상하부를 통과 → 대뇌 겉질의 중심 후방 뇌회에 이르면 감지

-(1) 급성충수염 ★

증상	• 주증상은 복통 처음에는 배꼽 주위에서 시작 → 우하복부로 옮겨 가서 그곳에 국한 (위치 변화O) • 복통 발생 후 식욕 감퇴, 오심, 구토 중 하나 이상의 증상이 나타남 * 구토→복통 : 위장관염 복통→구토 : 급성 충수염
진단	• McBurney point에 압통점 • 복부 촉진 시, 통증 부위에서 먼 곳(대개 좌하복부)부터 시작하여 복부 전체를 손가락 끝으로 가볍게 만져봐야 함 → 압통, 복근강직, 표면 종괴 유무를 알 수 있음 • 조기 진단이 중요 충수염 수술은 간단하나 이게 터져버리면 범발 복막염이 되므로

한방 병명	• 장옹(腸癰) : 급성 충수염의 한의학적 병명 • 치법 : 通利攻下, 清熱解毒, 活血化瘀, 排膿 처방 : 대황목단피탕, 의이인탕, 계지가대황탕
-------	--

(2) 장중첩증 ★

정의	• 상부 장이 하부창자 속으로 망원경 같이 말려 들어가는 것 • 5~11개월 영아(특히 남아)에게 호발 • 원인 불명: 위장관 감염이나 새로운 음식단백 항원에 의해 유발된 회장의 림프조직 종창이 돌막창자를 끌고 들어가서 유발한다는 설이 있음)
증상	• 건강하던 아이가 별안간 심한 복통으로 울기 시작 • 복통 발작이 1~2분 계속된 후 5~15분쯤 멎기를 주기적으로 반복 • 발작 중에 아기는 창백하고 복벽이 이완되며 축 늘어짐 • 발병 후 수 시간이 지나면 특징적 혈성 점액성 대변을 봄 • 다리를 배 위로 끌어당기며 이때 구토를 동반하기도 함 • 장중첩증의 3대 증상: 구토 복통 혈변
진단	• 주기적 산통, 구토와 혈변, 복부에 소시지 모양의 덩어리를 촉진
확진 및 치료	• X선 검사(바륨관장)로써 확진되나 치료목적으로도 이용됨

(3) 장간막림프절염

발생기전	• 말단 회장부의 장간막에 모여 있는 림프절의 바이러스 감염 or 다른 염증에 의해 발생
특징	• 대개 상기도염이 선행 → 전신감염에 의한 림프조직의 반응

증상	• 발열, 구토, 우하복부 동통 (광범위한 복통 나타나기도) *충수염과 감별진단 필요 • 심한 복통으로 창백해지고 뒹굴다가도 곧 복통이 소실되기도 함
진단	• CT, 초음파상 림프결절 비대 관찰 가능. 조직검사로 확진 • 림프절 비대는 급성 충수염에서도 동반될 수 있으므로 감별에 주의할 것

(4) 장폐쇄증

주증상	복통, 구토, 변비
원인	• 신생아기 : 선천성 장폐쇄, 거대결장 • 영유아기 : 장중첩증, 헤르니아 염전
진단	복부 X선 검사

(5) 급성 위장염

- 세균성 위장염일때는 복통 심함, 구토, 백혈구증가증 등이 나타남
- 영유아에서는 설사가 나타나기 전에는 급성 외과적 복통과 감별 요함

(6) 변비

- 구토까지 있을 때에는 급성 외과적 복통과 감별을 요함
- 대부분 체온이나 백혈구 수는 정상
- 변비 의심 시 복막 자극 증상만 없으면 관장으로 배변이 되면서 복통소실

(7) 급성 감염성 질환

- Enterovirus, adenovirus, influenza, Yersinia 감염 시 심한 복통
- 이때 장관의 염증 및 장간막림프절염으로 인하여 복통
- 복통 이외에 다른 증상을 동반하기 때문에 진단 가능
- 급성 편도염, streptococcus 감염성 인두염, 폐렴(우, 하엽) 때에도 복통이 올 수

있음

- 복통 이외에 다른 증상을 동반하는 것이 진단 point

(8) 전염성 간염

증상	복통 + 권태/구역질/구토/식욕부진 등 소아 연령에서도 비교적 많이 볼 수 있는 질환
진단	• 외견상 황달이 있을 때 진단이 용이 • 황달이 없는 경우 혈청 GOT, GPT 상승이 진단에 도움

(9) Henoch-Schonlein 자반증

증상	• 환자의 2/3에서 복통 호소 • 산통성 복통, 심하면 구토 • 소아에서 흔히 볼 수 있는 질환
진단	• 자반+복통이 함께 발생하면 진단이 용이 • 영아기 이후 (특히 5세 이상) 에서의 장중첩증인 경우, 의심 가능

(10) 심인성 복통

- 기질적 원인이 없을 뿐만 아니라 그것이 정신성 또는 심인성 요인과 관련되어 있는 것을 발견하는 수가 多
- 어린 아기가 먹기 싫어하는 음식을 강요했을 때, 긴장/불안/공포를 조성하는 환경에 처해 있을 때 등등
- 무의식적 또는 의식적으로 복통을 호소함으로써 이득을 얻으려고 주장하는 경우 有

(11) 기타

- 급성 신염 / 신산통 / 담낭염 / 류마티스열 / 급성 췌장염 / Meckel 게실염 / 난소낭종, 난소낭종의 염전 / 납중독 / 혈액질환

2) 만성 반복성 복통

- 4~16세 사이 소아에서 3개월에 3회 이상 반복적으로 발생되어 일상생활에 지장을 초래

	(1) 기능성 복통의 특징 (70-75%)	(2) 기질적 원인에 의한 반복성 복통의 특징 (10%)
발병 연령	4 ~ 14세 연령	4세 이하의 소아
발병 부위	대개 배꼽 주위에서, 일부는 심와부에서 복통 호소	복통이 배꼽 부위에서 멀다(Apley)
통증 양상	통증 정도는 다양 수분 ~ 대개 1시간 이내	수분 ~ 수일 간 지속되는 복통이 갑작스럽게 발생
통증 전파	타 부위로 통증 전파 X	통증이 등, 어깨, 사지로 전파
동반 증상	음식, 배변, 배뇨 or 전신활동과 연관성 X	배뇨장애 직장출혈 · 토혈 · 빈혈 체중감소 · 발육부진 발열
진단	진찰 및 검사 소견에서 기질적 증거 X	소화성 궤양, 염증성 장질환, 결핵 등의 가족력
기타	• 복통 없는 시기에는 정상 일상생활 • 육체적 or 심리적으로 스트레스를 받는 요인 有	• 야간에 복통으로 잠에서 깸 • 변비, 설사, 유분증이 동반되는 경우 • 구토 (특히 담즙이 섞인 토물)이 나오는 경우

(1) 기능성 반복성 복통 * 기능성 반복성 복통에 해당하는 대표 질환 3가지	
① 발작 복통	• 복통은 서서히 시작해서 1시간 내에 끝나며, 지속적 통증은 10%에 불과 • 90%에서 통증은 배꼽주위 또는 심와부 중간부위에서 끝남 • 동반 증상 : 두통, 안면창백, 오심, 현기증, 피로감 등
② 비궤양 소화 불량증	• 주로 심와부, 우상복부, 좌상복부에 나타나지만, 어릴수록 배꼽주위에 나타남 • 증상 : 구토, 식후 통증 • 동반 증상 : 오심, 가슴앓이, 역류증, 조기 포만감, 고창, 복부 팽만, 가스 방출
③ 과민장증후군	• 사춘기에 흔함. 복통은 배변으로 소실 • 통증의 모양은 발작성 복통과 유사하며, 불규칙한 배변 형태를 보임

[치료]

- 환경개선, 식이요법, 약물요법 및 심리요법
- 환자/부모/의사의 입장으로 나누어 문제를 해결
- 의사: 환자의 부모에게 복통의 존재와, 스트레스로 인하여 장이 과민해서 발생하는 기전을 잘 설명하고, 중대한 기질적 질환이 없음을 확신시킴
- 환경개선: 통증을 유발하는 정서적인 원인에 의한 만성 복통 환자
- 전환반응, 우울증, 부모가 복통을 다룰 능력이 상실되거나, 환경을 개선시켜도 일상생활에 복귀가 안 되는 경우는 정신과 전문의와 함께 진료

(2) 기질적 원인의 반복성 복통

- 감별해야할 주요 기질적 질환 : 젓당 불내성 | H.pylori 감염증, 세균 또는 바이러스 위장염, 궤양 결장염 | 크론병, 위식도역류증
장결핵, 장의 회전이상, 소화궤양 | 담관질환, 췌장질환 | 복부궤양, 복성편두통,

복성간질 | 요로감염증, 부인과적 질환 등

복성간질

- ① 증상 : **반복성, 발작성** 복통. 복통발작이 배꼽 주위 or 위완부에 **疝痛(산통)**으로 나타남 (吐氣, 구토 동반 가능)
- ② 간질 발작의 전구증의 하나로 볼 수 있으며, 복통이 간질의 유일한 증상으로 나타날 수 있음
- ③ 뇌파 검사상 수분 ~ 수시간 동안 이상소견을 보일 수 있음
- ④ **항간질제 (=항경련제)** 를 투여하면 복통이 완화됨